

泰合

(6467 TT, NT\$143.5, 未評等)

重點摘要

1. BEQIA (TAH3311) 歐美藥證進度明朗：核心產品抗血栓口溶膜 BEQIA 已於 2026/6/19 重新向美國提交 NDA，資料 100% 備齊，預計 2Q27 取得美國藥證；歐洲方面則於 10M25 送件，預計 4Q26 獲得歐盟上市許可。
2. 長效劑型 (TAH3341) 戰略布局：利用 TDS 技術平台自主開發全球首款一日一次緩釋抗血栓口溶膜 TAH3341，目前處於臨床前動物實驗階段，預計 1H27 進行人體臨床一期並同步展開授權談判，藉此建構新專利以無縫轉移原一日兩錠市場。
3. 公司持續推進雙軌平行授權策略（原廠與非原廠並行），已與歐、美、紐澳、拉美等地區數十家專科藥廠簽訂保密協定並洽談授權條件，策略上優先展開美國以外區域之授權談判；同時規劃於 2 年內建立自有工廠，以確保產能並強化授權談判籌碼。

結論

泰合核心產品 TAH3311 美國 NDA 已於 6 月重新送件並確認資料齊備，美國、歐洲藥證分別鎖定 2Q27 與 4Q26 取得，產品上市與商轉時程已逐步明朗。同時，公司積極推進長效劑型 TAH3341 的臨床前開發，並持續在全球展開雙軌授權談判。未來，公司將擁有多元營收來源，包含簽約金、階段里程碑金、銷售權利金，以及透過委外代工再轉出貨予合作夥伴所鎖定的代工價差利潤；長期並規劃透過自建工廠切入 CDMO 業務，以進一步擴大長期穩定的獲利規模。

公司平台技術與核心產品 BEQIA 定位

- 泰合生技為特殊技術平台公司，核心技術為 TDS (Transepithelial Delivery System，穿透上皮細胞藥物傳輸系統)，可將原劑型改製為皮膚貼片、舌上/舌下溶膜、口頰溶膜四大類；FDA 迄今僅核准 23 張貼片、11 張口溶膜、4 張口頰溶膜藥證，技術門檻高
- 核心產品 BEQIA (TAH3311, Apixaban ODF) 為全球首款針對吞嚥困難者設計之抗血栓口溶膜，原廠 BMS/Pfizer 共有之 Eliquis 錠劑由泰合改製為口溶膜，鎖定非瓣膜性心房顫動(NVAF)、深層靜脈血栓、肺栓塞三大長期用藥適應症
- Eliquis 為全球最大小分子藥物，2025 年美國市場規模約 290 億美元、YoY 維持 12-18% 成長；2025 年受美國藥價下修政策影響，單錠價格自 8-10 美元砍至約 3.8 美元，惟市場仍持續成長

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

原廠 BMS 財務表現與藥物經濟學支撐

- 原廠 BMS 1Q26 美國市場營收 YoY 16%、2Q26 YoY 21% (QoQ 8%)，2026 年全年銷售額財測由原 10-15%上調至 20-25%，顯著高於 2025 年約 12%成長率；新增患者流向 Eliquis (New-to-Brand share) 比例持續高達約 80%
- 藥物經濟學支撐處方剛性：心房顫動病患一旦中風住院，每人年醫療費用達 46,700 美元，一年 45 萬名病患住院將產生 210 億美元醫療照護費，相對地服藥一年僅需 2,772 美元
 - 全球每年新增中風患者達 1,500 萬人，一旦中風需終生服藥；若漏藥或服藥不規律，二次中風風險跳升 25-40%，且患者一年內二次中風機率超過 50%

藥證與長效劑型研發進度

- 美國：BEQIA 已於 2026/6/19 重新提交 NDA，資料 100%備齊且符合法規要求，預計 2Q27 取得美國藥證
- 歐洲：10M25 已送件，預計 4Q26 獲得歐盟上市許可
- 長效劑型 TAH3341 (一日一次緩釋口溶膜) 目前處於臨床前動物實驗階段，預計 1H27 展開人體臨床一期；旨在解決現行一日兩片劑型易漏藥、血中濃度波動之痛點，成功後可無縫轉移原有市場並建構新專利保護傘
 - 參考案例：惠氏(Wyeth)抗憂鬱藥由短效錠劑 (銷售額 3.8 億美元) 轉為長效緩釋劑型(XR)後銷售額放大近 9 倍達 32.8 億美元；抗血栓藥物若漏服後果較憂鬱症復發更嚴重 (可能致命中風或全身性栓塞)

口溶膜劑型優勢與吞嚥困難藍海市場

- 高齡族群平均 50-75%面臨吞嚥障礙，需照護人員磨粉給藥 (一日兩次)，Apixaban 不溶於水、磨粉後易堵塞鼻胃管且劑量不精準，提高二次中風風險；口溶膜可完全免除此痛點
 - 吞嚥困難盛行率：失智症患者 68%、中風後患者 50%、老年族群 50-75%、慢性肺阻塞(COPD)27%、運動神經元疾病及頭頸癌患者 50-80%
- 2025 年美國心房顫動(AF)患者約 1,050 萬人，65 歲以上占 75% (約 791 萬人)；其中 50-75%伴隨吞嚥困難，換算約 395-593 萬人為口溶膜絕對目標族群，以每月藥價約 231 美元計算，美國潛在目標市場(TAM)一年高達 110-164 億美元
- 抗凝血藥市場中，美國目前僅 30%心房顫動患者用藥，尚有 70%空白市場；泰合走 505(b)(2)新劑型新藥高價值法規路徑，專利期長達 20 年 (與原廠合作可再延長 20 年)
 - 劑型創造溢價案例：偏頭痛藥 Rizatriptan 由 Merck 開發口溶錠後與傳統錠劑市場比例達 40:60，零售單價較傳統錠劑享有約 20%溢價；舌下戒毒藥 Suboxone(原廠 Indivior)專利到期前推出口溶膜後幾乎完全取代口溶錠，售價達學名藥 3-5 倍 (台灣 6-10 倍)

雙軌授權策略與原廠困境

- 原廠 BMS 的 Eliquis 占其總營收約 30%，專利懸崖將衝擊營收與股價且缺乏其他重磅新藥，僅開發兒童小兒粉劑（僅美國專利延長 6 個月）；泰合因此採取原廠與非原廠並行之雙軌平行授權策略
- 與原廠合作可完全規避專利壁壘（美國物質專利 DS patent 至 5M27、製劑專利 DP patent 至 10M31），並藉原廠通路快速推升滲透率；與非原廠合作則鎖定年營收 10-100 億美元、具新劑型新藥銷售實績之專科大廠，採區域分擊策略優先於美國以外地區談判
- 已與歐、美、紐澳、拉美等地區數十家業者簽訂保密協定並洽談授權條件，合約將訂定最低採購量(MOQ)條款，若夥伴銷售不力可收回獨家授權並更換對象

未來展望

- TAH3311 歐洲預計 4Q26 取得藥證並完成授權談判、2027 年開始銷售（紐澳跟隨歐洲進度）；美國預計 4Q26-1Q27 完成授權、2Q27 取得藥證、2028 年產品上市
- 其他管線：肺纖維化口溶膜(TAH0031 Nintedanib)可避開肝臟首渡效應、大幅提高生體利用率；鴉片過量解毒口溶膜(TAH2231 Naloxone)全球授權談判進展順利，預計與夥伴共同執行三期臨床
- 規劃 2 年內建立自有工廠(CDMO)以確保產能與利潤並強化授權籌碼；TDS 平台技術本身已為 3 家美國藥廠開發劑型（其中 2 家已完成）

QA

- 美國 NDA 送件後 60 天確認期進度為何？原廠會何時採取專利訴訟動作？
 - FDA 收件後有 60 天確認期，期滿未要求補件即進入實質審查；確認期滿 20 天內須依法向原廠發出專利通知信，說明無侵權理由與專利分析；原廠收到通知信後須於 45 天內向法院提出訴訟
 - 目前已與原廠 BMS 有初步非正式接觸；因 Eliquis 由 BMS 與輝瑞共有、雙方過去已有多起官司且該藥物營收龐大，原廠對此案極為重視
- 保險公司對口溶膜產品願意提供多少定價溢價？
 - 定價策略均以原廠藥 Eliquis 價格為基礎上下調整，改為口溶膜通常可獲得約 20% 溢價；與原廠合作則對吞嚥困難病患加價 20-30% 銷售，與非原廠合作則多採略低於原廠價 10% 之競爭定價搶市；對輕中度吞嚥困難病患則定價貼近原廠以加速取代
- 授權合約架構中，應對哪個部分期待最大？
 - BEQIA 對應市場達 290 億美元且專利期尚餘 15 年以上，故以合作總收益絕對值最大化為核心考量；國際標準授權合約含簽約金、階段里程碑金（含取得藥證、產品首批銷售等）與銷售權利金(Royalty)

- 此外公司另握有委外代工價差(CMO margin)：合約要求夥伴向泰合下單、委託全球最大代工廠量產後再加價出貨，可帶來穩定長期獲利
- 泰合相較同業有何優勢？
 - 同業改劑型之原廠藥多為規模較小藥物，泰合改劑型的 Eliquis 則是全球最大小分子藥物；泰合已完成三期臨床、進入等候藥證階段，臨床風險趨近於零，市場規模為同業數十倍以上，早期授權常見的膨脹式里程碑金風險亦大幅降低
- 若原廠 BMS 提告，藥證審查是否受影響？
 - FDA 藥證審查與專利侵權訴訟分開進行；美國專利法規下原廠提告可申請最長 30 個月停審期，惟 505(b)(2)新劑型官司僅需證明無侵權（無須證明原廠專利無效），通常不致拖延過久
 - 觀察 BMS 原廠 2023-2024 年三件學名藥訴訟，最短 15 天、最長 2.5 個月即達成和解；若原廠惡意拖延亦將面臨濫訴指控與反托拉斯法調查風險
- 歐、美、日等市場授權與定價規劃為何？
 - 各地授權完全獨立進行，優先順序為美國以外地區、其次歐洲、最後美國；定價普遍以原廠藥價為基準上下調整
 - 日本核價機制較特別，並未給予 505(b)(2)新劑型獨立健保溢價通道，直接比照學名藥核給原廠藥價六折，目前尚未對日本市場進行具體規劃
- 授權對象如何篩選、確保夥伴行銷能力？
 - 針對洽談之跨國藥廠進行嚴格盡職調查，徹查其負責之 Territory、年營業額、既有藥品組合與過去新劑型新藥銷售實績，並要求提出具體行銷規劃與銷售預估，合約中明訂 MOQ 條款

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬= (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。